הפרוטוקול

סבב אחרון לאיתור נזקים	S	✓ בטיחות המטפל והמטופל – הרחקת הפצוע מאיום ✓ התרשמות מזירת האירוע – סיפור המקרה, מנגנון הפציעה, בחינה ויזואלית ✓ עצירת דימומים פורצים ע"י לחץ ישיר/חסם עורקים/נקודת לחיצה/Packing (ע"פ ההתוויות) ✓ דיווח ראשוני לרמה ממונה
	A	✓ בדיקת הכרה A.V.P.U ✓ התרשמות מדרכי האוויר ✓ פתיחת פה, סילוק ושאיבת הפרשות במידת הצורך ✓ במידת הצורך : הסרת קסדה ✓ בפצוע עם חשד לפגיעת עמש"צ ע"פ מנגנון (לרבות פצוע מחוסר הכרה עם מנגון פגיעה לא ברור) – שמירה על עמש"צ (**מט"ב** : הנחת חלק אחורי של צווארון) ✓ בפצוע שאינו מגיב לכאב –ביצוע JT והחדרת AW ✓ התרשמות מאזור הצוואר - המטומה צווארית, גודש ורידי צוואר, התרשמות מסימני חריכה וכו'
	B	✓ חשיפת בית החזה - התרשמות מחבלות קהות/חודרות והתפשטות דו צדדית (מישוש ו/או האזנה) ✓ הערכת נשימה איכותית (סימני מצוקה) וכמותית – 30 שניות ✓ מדידת רוויון חמצן (סטורציה) כמותית ✓ העשרה בחמצן ✓ סיוע נשימתי לא פולשני באמצעות אמבו ומסיכה על פי הצורך
	C	✓ חיפוש אחר מקורות דימום לחיצים בגפיים ובאיזורים נסתרים - עורף, בתי שחי, גב, גפיים, עכוז ומפשעות ✓ עצירת דימום- כולל חבישה המוסטטית (Packing) וחבישות לחץ ✓ בדיקת דופק כמותי – בדיקת דופק פריפרי (רדיאלי) למשך 15 שניות (במידה ולא נימוש רדיאלי, למדוד דופק קרוטידי) ✓ **מדידת לחץ דם כמותית** ✓ **מט"ב: בחשד לחזה אוויר בלחץ, יש לבצע טיפול לפי פרק "פציעות חזה" - ניקור חזה וקידום שימוש במוצרי דם** ✓ התרשמות בהסתכלות מסימני חבלה בבטן ✓ הערכת האגן **וביצוע כריכת אגן** על פי ההתוויות ✓ העברת דיווח **ותיעוד בטופס 101** ✓ **במידה והפינוי זמין מיד לאחר שלב זה - יש להשלים את יתר שלבי הסכמה במהלך הפינוי**
	D	✓ הערכת מצב הכרה חוזרת לפי A.V.P.U וכן GCS (עבור מט"ב) ✓ בדיקת אישונים (עבור מט"ב) ✓ התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ✓ הנחת חלק קדמי של צווארון בפצוע עם חשד לפגיעת עמש"צ

	E	✓ השלמת הפשטה **מלאה** והפיכה ✓ עצירת דימום במידה ומזוהה רק בשלב זה ✓ מניעת היפותרמיה - כיסוי והעמסת הפצוע לאלונקה ✓ סיכום הממצאים, הגדרת דחיפות הפינוי והתוכנית הטיפולית ודיווח
	סקר החייאה	✓ **השגת גישה וסקולרית והחזר נפח לפצועים בהלם עמוק** (דם מלא/ פלסמה/נוזלים- על פי ההתוויות וסמכויות המטפל). ✓ ביצוע פרוצדורות מצילות חיים על פי ההתוויות (אינטובציה/נקז חזה וכו') ✓ מתן של TXA ע"פ ההתוויות. ✓ קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס על פי ההתוויות ✓ השלמת **טופס 101** ✓ הערכה חוזרת של GCS ✓ ניטור רציף ✓ הערכת כאב **כמותית** (חובש : נסבל/בלתי נסבל) **וטיפול בכאב**
	סקר שניוני	✓ הערכות חוזרות של חוסמי עורקים – הידוק במידת הצורך, המרת חסמי עורקים במקרים בהן ההנחה הייתה נסיבתית ועל פי ההתוויות וסמכויות המטפל (חובש- עד שעתיים, מט"ב עד 6 שעות). ✓ מתן טיפול אנטיביוטי במידה ומדובר בפציעה חודרת ומשך הפינוי מוערך מעל שעה. ✓ השלמת עירוי פריפרי שני בנפגע אשר נזקק למוצרי דם. ✓ בדיקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים – טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך (שטיפת פצעים, קיבוע שברים, חבישת כוויות וכיוצ"ב). ✓ השלמת חבישות שלא נועדו לעצור דימום פורץ ✓ הערכה ראשונית לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהלו"ם במידת הצורך
	טיפול מתמשך והחזקת פצוע לאחר הסקר השניוני (PFC)	✓ בפצוע מונשם : החדרת AW (Bite Block), חיבור למנשם אוטומטי, כיוונונו ווידוא הנשמה תקינה, הכנת תרופות הרדמה להמשך. ✓ בפצוע שקיבל TXA – במידה וחלפו 3 שעות מהמנה הראשונה מתן מנה נוספת. ✓ הכנס צנתר שתן (בסמכות רופא בלבד) ע"פ ההתוויות בפצועים אשר צפויים לעיכוב פינוי בהתאם למפורט בפרק סקר שניוני. ✓ הכנסת זונדה לניקוז הקיבה (בסמכות רופא בלבד) בפצוע מונשם – דרך הפה בלבד, במתארים בהם קיים עיכוב בפינוי ובהתאם לפרק סקר שניוני